

Диагностическая колоноскопия в амбулаторной практике

Бектурсынов С.М., Менисов Б.К.

ГККП «Областной онкологический диспансер»

г.Талдыкорган

Ценность колоноскопии в диагностике доброкачественных, а также злокачественных заболеваний толстой кишки не вызывает сомнения. В данное время по всему миру, в том числе и в республике Казахстан на фоне урбанизации и старения населения отмечается рост заболеваемости колоректальным раком. В связи с этим, колоноскопия как метод диагностики всех патологий толстого кишечника, в том числе и рака имеет неоспоримые объективные преимущества перед другими диагностическими методами (Никифоров Н.Н. с соавт.2005 г.)

Показанием к колоноскопии является появление клинических признаков, прямо или косвенно указывающих на поражение толстой кишки, а также наличие известных факторов риска по развитию злокачественных заболеваний, включающих возраст больных, превышающий 50 лет. Однако в амбулаторной практике имеются определенные препятствия относительно технической сложности проведения манипуляций и возможность развития тяжелых побочных эффектов и осложнений. В областном онкологическом диспансере г.Талдыкорган мы проводим колоноскопические исследования амбулаторным пациентам с 2008 года. Подготовку кишечника проводим лаважным методом с применением препарата «Фортранс», которое не всасывается в кишечник, достигается эффективный лаваж при пероральном приеме, не сопровождается существенными побочными явлениями. Основные больные к нам обратились по поводу подозрения на опухоль толстого кишечника. Пациенты с различными формами поражения толстой кишки, подтверждают его высокую эффективность и получают хороший результат в 95 % случаев. При этом ухудшения состояния пациентов отмечено не было. Медикаментозное сопровождение колоноскопии в большинстве случаев не проводится.

За 2 года (2008 – 2010) нами проведено 257 исследований толстой кишки, возраст пациентов был от 40 до 75 лет. Преобладали мужчины - 240 (68,21%). В результате анализа полученных данных полипы и полиповидные образования толстой кишки выявлены у 58 пациентов (22,6%), рак толстой кишки у 144 пациентов (55,7%), т.е. онкологическому

Қазіргі таңда әлемде және де Қазақстан Республикасында колоректальды обырдың көрсеткіштерінің ұлғаюы байқалады.

Осыған орай, тоқ ішектің қатерлі, қатерсіз өспелерін анықтауда колоноскопия басқа зертеу әдістерінен басым екендігі, баға жетпестігі мүмкінсіз.

Колоноскопияға көрсеткіш – тоқ ішектің зақымдалуының клиникалық белгілерінің пайда болуы, сонымен қатар осы белгілердің қауіп-қатер факторы, яғни, 50 жасан асқан адамдарда болуы.

Тоқ ішекті зертеуге дайындауда Фортранс препараты қолданамыз. Бұл препаратты қолдану арқылы зертеудің нетижелілігін арттырдық.

Диспансерде 2008 -2010 ж.ж. аралығында 257 зертеу жүргізілген. Шағымданушылар негізінен 40 – 75 жас аралығындағылар. Жынысқа бөлсек ер адамдардың үлесі басым – 240 (68,2%).

2 жылдың зерттеу нәтижелерін қорытындылай келе, тоқ ішектің обыры 144 (55,7%), тоқ ішектің қатерсіз өспелері - 58 (22,6%) екендігін анықтау мүмкін болды.

Сөзімді қорытындылай келе, колоноскопия тоқ ішектің өспелерін, обыралды патологияларын анықтауда ең басты әдіс екендігін тағы да бір рет айта кетуім керек!

Бұл әдісті жалпы емдеу желісінің емханаларына енгізудің болашағы зор!

учреждению из общей лечебной сети в основном направляются на подозрение рака, НЯК и болезни Крона у 37 (14,3%).

Таким образом, амбулаторная колоноскопия является важным методом в диагностике заболеваний толстой кишки, выявления предраковой патологии, и рака прямой и ободочной кишки имеют перспективы внедрения в поликлинические учреждения ПМСП РК.